06. EL CORAZÓN : INTRODUCCIÓN Y ORÍGENES

DURACIÓN : 11:43 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una introducción profunda al papel central del corazón en el desarrollo embrionario. El corazón, que comienza a latir a partir del día 21 de la vida intrauterina, desempeña un papel crucial en la distribución de la información, influyendo en el tubo neural y el sistema digestivo a través de mecanismos autocrinos y paracrinos. También se aborda la interdependencia entre el corazón del niño y la salud de la madre, destacando que los niños están energéticamente ligados a su madre hasta los 7 años, un momento importante de su desarrollo. También se exploran los orígenes primitivos del corazón, su posición asimétrica y las polaridades establecidas desde la fecundación, ilustrando así la compleja interacción entre la biología y la embriología, y cómo esto influye en la salud futura del individuo.

EL CORAZÓN: INTRODUCCIÓN Y ORÍGENES

EL CORAZÓN, MOTOR DEL DESARROLLO

Su **corazón** comienza a latir el **día 21** de la vida intraembrionaria. Después de tres semanas, es el primer sistema en funcionar y mantendrá esta función toda su vida: la **distribución de la información**.

Tan pronto como el corazón late, el proceso de **crecimiento** se acelera. El primero en recibir esta gran información del corazón es el **tubo neural**, todo el cerebro.

Es el corazón el motor, el que va a aspirar. Existe una relación muy importante y funcional entre el corazón y el cerebro. Es el corazón el que le dará fuerza al cerebro.

Estudios han demostrado que en el **sistema ventricular profundo**, existe una vibración pulsátil directa del corazón que informa al cerebro. Hay un vínculo directo, a niveles muy sutiles.

EL CORAZÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El corazón distribuye la información. ¿Pero qué información? Distribuye el **"alimento"**, en estrecha relación con el **sistema digestivo** y el vínculo con la madre.

Usted aporta una información trófica organizada por su corazón y redistribuida por su sistema. Por lo tanto, usted depende de su **endodermo**, de su sistema digestivo, en su desarrollo.

Autocrino, **paracrino**, digestivo, y solo después el sistema aparece visiblemente.

EL CORAZÓN DEL NIÑO Y EL VÍNCULO MATERNO

Cuando trabajamos en este vínculo con un niño, a menudo es necesario tratar a la **mamá**. Si la mamá no está libre en su función, el niño tampoco puede liberarse, porque dependerá energéticamente, al menos hasta los **7 años**.

A nivel energético celular, todas las células de su cuerpo se renuevan a los 7 años. Esto se llama **"el nuevo cuerpo"**. Es su primer nacimiento, el momento en que puede tener **"la razón"**.

Es el momento en que su **seno frontal** se abre y su **tiroides** se vuelve completamente eléctrica, porque ha re-informado a su corazón. Por eso se puede sentir el corazón a distancia.

Está informado por la **cresta neural** y ha transmitido su información. A los 7 años, el niño puede defenderse en su entorno, encuentra su primera independencia.

ORIGEN PRIMITIVO DEL CORAZÓN

El esbozo del corazón aparece en el **mesoblasto esplacnopleural**, en un plano primitivo. De nuevo, dependerá de todo el **sistema vitelino**.

Aquí encontramos una fuerza presuntiva del corazón antes de la **gastrulación** y antes del plano vascular, a lo largo de las células **cardiogénicas** del epiblasto. Ya tiene todo su campo de posibilidades.

Cuando tomo un **sacro** o un **cóccix** y me pongo en el sistema, ya tengo la historia del corazón que se presenta. Por lo tanto, debo comenzar a tratar el corazón liberando la **línea primitiva**, bajo esta primera ola que se desarrolla.

RUPTURA DE SIMETRÍA Y POSICIÓN DEL CORAZÓN

La ruptura de la **simetría** se produce desde la implementación del proceso **notocordal**. Hay un flujo nodal con pequeños cilios que llevan vesículas cerebrales de derecha a izquierda, a través de la sonética **HH**, el **FGH8**, y finalmente un cambio de ácido **retinoico**.

Esto induce un cambio en el plano **cálcico** que da una integración diferente en la información genética. Al final, hay una ruptura de la simetría de derecha a izquierda, donde se da una información importante a este nivel.

Esta ruptura de la simetría será uno de los factores que posicionará el corazón hacia la izquierda en el futuro. Esto se hace por **moléculas morfogenéticas**, con un aumento de la tasa de calcio en toda una lámina lateral, y por lo tanto toda la información de la integración genética será diferente.

Esta asimetría se produce entre la base del cráneo y el sacro, con la línea primitiva. La desviación está presente: es un flujo que va de derecha a izquierda.

POLARIDAD E IMPACTO DEL ESPERMATOZOIDE

Esto se encuentra en otro nivel por las **células nutricias foliculares** que liberan enzimas. Ya crean una **polaridad** dentro del ovocito, en el citoesqueleto.

Una primera polarización se produce en un plano **cráneo-caudal** y **dorsoventral**, aunque el ovocito aún no está informado de su entorno exterior.

Se observa que el lugar de penetración del **espermatozoide** dará una re-información en el eje longitudinal del embrión, donde se creará esta fuerza presuntiva.

Esta integración ya es una información del exterior por la fuerza del espermatozoide que reestructura la fuerza del citoesqueleto en un plano casi **electromagnético**. Algunos describen que esto se encuentra en la parte apical del embrión.

Esto significa que se capta un campo presuntivo de información. Y es en este campo presuntivo donde se encontrará la futura fase **cardiogenética**.

El espermatozoide ya representa, de alguna manera, la fuerza cardíaca, la pulsación que se prepara allí. Pero aún no hay forma aquí, es una preforma.

ORGANIZACIÓN DEL EMBRIÓN Y FORMACIÓN DEL CORAZÓN

Veremos muy pronto que toda una organización del embrión se desarrollará con la famosa **"ola"**, con un punto de apoyo aquí, y un punto de apoyo allá, con la línea primitiva, y con la reintegración de este sistema.

La importancia de estos puntos es crucial. El segundo punto será el momento en que tengo la ola, es decir, el paso de la implementación de mi **tercera cámara embrionaria**, el **celoma** o el **lecitocele externo**.

Esto reorganizará el embrión y creará una estructura en forma de **S**. Es en este momento cuando tendré la integración con respecto al punto de unión, y esto es lo que da mi línea primitiva. En un embrión, el corazón está ahí.

EL CORAZÓN, EL PERICARDIO Y EL DIAFRAGMA

El corazón ha encontrado su lugar, ha integrado el **pericardio** y el **septum transverso**, con estos **pilares diafragmáticos** que se convertirán en un punto de apoyo para el sistema cardíaco.

Tratar un corazón es liberar el diafragma, ya que es su orientación lo que hace esto. El diafragma se convierte realmente en nuestra herramienta terapéutica, ya que las células pericárdicas son las mismas células que se encontrarán en el plano del septum transverso, es decir, del diafragma.

¿De dónde toman su origen? Tengo mi corazón, y ahí tengo pequeñas células **mesenquimales** que formarán mi diafragma. El ectodermo crece a fondo, y esto se balancea, y formará todo este sistema.

EL IMPACTO DEL RECONOCIMIENTO Y LA FERTILIDAD

El espermatozoide llega, y la **"clave"** está ahí para el encuentro. La píldora ha matado el concepto, la posibilidad de conceptualizar. Se ha cortado el sistema hormonal durante años.

Cada vez más mujeres tienen dificultades para concebir. Un nivel médico intervino diciendo: "Ahora, podemos ayudarla". Se hacen lo que se llama **"IMSI"**, donde se toma una aguja, se pincha y se atraviesa la membrana.

Se espera estar en el lugar correcto con respecto a la polaridad. Excepto que no se tiene el primer reconocimiento, que es un reconocimiento membranoso, coronario, tisular, molecular.

Probablemente, estos niños tendrán cada vez más problemas de fertilidad. Por lo tanto, ya no sabrán reproducirse ni reconocerse. Se ha eliminado el primer reconocimiento.

A estos niños que vienen a consulta, hay que reconocerlos. ¿Reconocerlos a qué nivel del cuerpo? Su corazón. Hay que contactarlos con la mirada en su corazón.

Si lo hace, el niño lo sabe. Es lo único que puede dar. "Puedo reconocerte, hacerte nacer de nuevo". De lo contrario, estas personas estarán buscando toda su vida.

POTENCIA METABÓLICA Y DESARROLLO INICIAL

Esto ya ocurre en su **sistema vascular primitivo**, al quinto o sexto día. El **cigoto** debe tener una potencia metabólica en un polo específico.

El **trofoblasto celular** debe transformarse en **sincitiotrofoblasto**. Este sincitiotrofoblasto tiene una actividad lítica para poder penetrar la mucosa. Si el embrión no tiene esta potencia, no puede entrar en la mucosa.

Segundo, la madre debe ser acogedora. Pero no es ella quien hace el trabajo por el embrión. ¿Ha recibido esta potencia?

Su potencia metabólica está determinada primero por una fase de **desdiferenciación celular**. Durante los tres, cuatro primeros días, el cigoto no crece.

Por el contrario, aumenta su **división celular**, en la segmentación, a gran velocidad. Hay un aumento global de la membrana, y una pequeña pérdida de agua al exterior.

Es ahí donde creará esta primera cavidad que llamamos **"germen del cielo"**, el **blastocisto**, que es una conexión específica de su **"cielo exterior"**.

Luego, a nivel celular, habrá un aumento de la membrana. Si la membrana aumenta, los intercambios aumentan. Las membranas son espacios de intercambio, siempre polarizados.

Si tengo una célula, tengo un núcleo, y veo que mi núcleo está concentrado. Es aquí donde tengo mi mayor fuerza de intercambio. En lugar de tener 50, voy a tener 3000.

Las células en esta fase de división se vuelven **200 veces más pequeñas** que los dos blastómeros originales. Relativamente, mi membrana aumenta.

Si tomo mi membrana con respecto a mis dos primeros blastómeros, diremos que son 100 metros. Si tomo todas estas pequeñas membranas, aumento enormemente.

Aumento mi potencia metabólica. Si tengo suficiente potencia metabólica, tengo suficiente fuerza para entrar.

LA POTENCIA METABÓLICA PARA LA VIDA

Esta potencia metabólica, siempre la necesitaré, toda mi vida. Es un poco la **"pila"** que va a recibir. Y debe confiar en ello.

Se regenera hasta cierto tiempo por su **sueño**, su **alimentación**, su **respiración**, sus pensamientos justos, etc. La degenera si no respeta esto y si está intoxicado.

Pierde sus sustratos fundamentales de esta potencia. Por lo tanto, necesita esto. El corazón toma su origen prácticamente en el contacto del espermatozoide, en este encuentro, de forma simbólica.

Después, la encontramos a nivel de la línea primitiva. Luego, una información ya de los campos cardíacos que se forman aquí en relación con la presencia de un edema sano, está en la ola de crecimiento del desarrollo de los campos cardíacos.

Y luego veremos una cosa que es muy importante, es todo este movimiento de desarrollo.

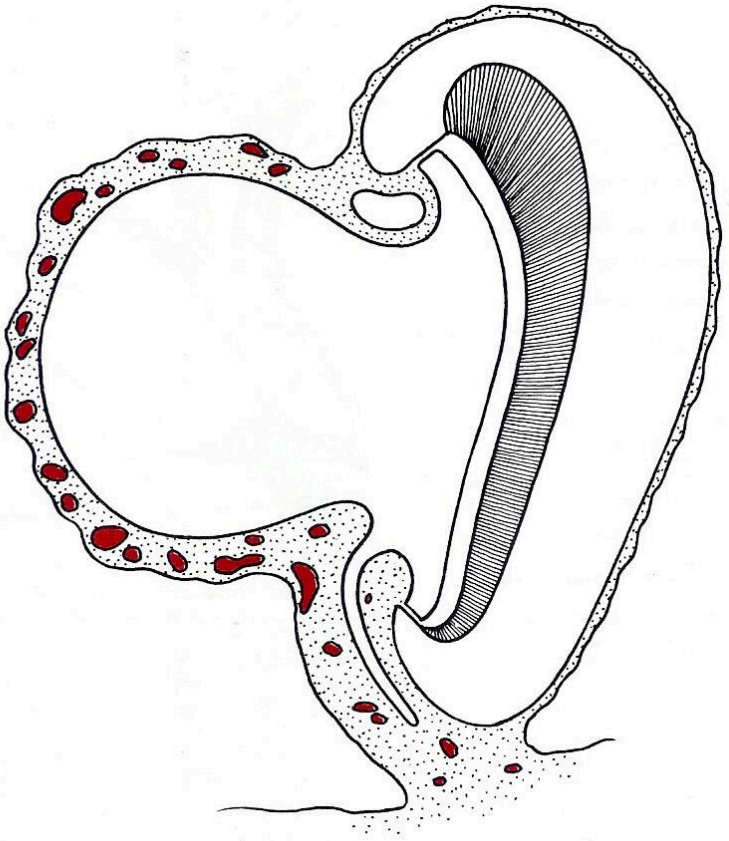


Fig. 1.— *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

FIG. — Embrión humano de 3 semanas